



130-275, boul. Armand-Frappier, Laval (QC) H7V 4A7

Prélevé 2026-03-06 09:01

Requérant

Médecin:

OUELLET-DECOSTE, ARIANE

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A 1H6

Tel: 514-400-7070, Fax :877-661-0185-AUTOFAX

Compte: VITALAB INC.

HÉMATOLOGIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
LEUCOCYTES	7.7	3.2 - 9.4	x10 ⁹ /L	
NEUTROPHILES #	5.0	1.4 - 6.3	x10 ⁹ /L	
LYMPHOCYTES #	2.1	1.0 - 2.9	x10 ⁹ /L	
MONOCYTES #	0.3	0.2 - 0.8	x10 ⁹ /L	
ÉOSINOPHILES #	0.3	0.0 - 0.5	x10 ⁹ /L	
BASOPHILES #	0.08	0.00 - 0.09	x10 ⁹ /L	
ÉRYTHROCYTES	4.5	3.8 - 5.2	x10 ¹² /L	
HÉMOGLOBINE	124	110 - 147	g/L	
HÉMATOCRITE	0.38	0.33 - 0.44	L/L	
VGM	85	76 - 98	fL	
HGM	28	24 - 33	pg	
CGMH	324	313 - 344	g/L	
CVGR	13.8	12.5 - 17.3	%	
PLAQUETTES	257	155 - 372	x10 ⁹ /L	
VPM	10.1	4.0 - 14.0	fL	

ENDOCRINOLOGIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
FERRITINE	82	30 - 223	µg/L	
Chez les patients avec une inflammation concomitante, utiliser les analyses du fer, incluant le pourcentage de saturation de la transferrine et la TIBC pour évaluer le statut de carence en fer.				
En absence d'inflammation concomitante, les niveaux de ferritine peuvent être interprétés de la façon suivante :				
30-50 : Carence en fer probable				
51-100 : Carence en fer possible, si les facteurs de risque sont présents.				
101-300 : Carence en fer peu probable.				
Pour des conseils, visiter www.hemequity.com/raise-the-bar				
25-OH Vit. D total	102	76 - 250	nmol/L	
Déficience: < 25 nmol/L				
Insuffisance: 25 - 75 nmol/L				
Suffisance : 76 - 250 nmol/L				
Toxicité : >250 nmol/L				
TSH	2.83	0.35 - 5.00	mIU/L	
FSH	<1		UI/L	
Folliculaire: 3.0 - 15.0				
Ovulatoire: 5.0 - 23.0				
Lutéale: 1.4 - 9.0				
Post-ménopausée: 16.0 -157.0				

Patient

F

50 Ans

SWO000017600

6788498

CONTRACTS QV

BIOCHIMIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
CRÉATININE	65	50 - 100	µmol/L	
ACIDE URIQUE	219	140 - 400	µmol/L	
Cible de traitement de la goutte: Acide urique sérique < 360 µmol/L (minimum)				
Une concentration sérique plus basse peut être nécessaire pour le soulagement des symptômes.				
[Arthritis Care Research 64 (2012) 1431-1446]				
ALT	10	<28	U/L	
SODIUM	140	136 - 146	mmol/L	
POTASSIUM	4.2	3.7 - 5.4	mmol/L	
CHLORURE	105	95 - 108	mmol/L	
CHOL. TOTAL	5.81	<5.20	mmol/L	
TRIGLYCÉRIDES	1.34	<1.70	mmol/L	
NON-HDL-C	3.71		mmol/L	
LDL CHOL. CALC.	3.10		mmol/L	
APO. B	0.88	0.60 - 1.17	g/L	
HDL CHOL.	2.10	1.30 - 2.30	mmol/L	
MAGNÉSIMUM	0.76	0.65 - 1.05	mmol/L	
HS-CRP	30.9		mg/L	
Risque faible: < 1.0 mg/L				
Risque modéré: 1.0 - 3.0 mg/L				
Risque élevé: > 3.0 mg/L				
HBA1C	5.5	<6.0	%	
Non diabétique: < 6.0%				
Prédiabète: 6.0 - 6.4%				
Diabète: > 6.4%				
Contrôle optimal: < 7.0%				
Contrôle sous-optimal: 7.0 - 8.4%				
Contrôle inadéquat: > 8.4%				
GLUCOSE HASARD	4.7	3.6 - 7.7	mmol/L	
3.6 - 7.7 mmol/L : Normal				
7.8 - 11.0 mmol/L : Risque possible de diabète; considérer de répéter à jeun				
> 11.0 mmol/L : Diagnostic provisoire de diabète				
DFGe (CKD-EPI)	100	>= 60		
Le DFGe est calculé à l'aide de l'équation CKD/EPI 2021 qui n'utilise pas d'ajustement fondé sur la race. Un résultat de DFGe >= 60 ml/min/1.73m ² écarte la possibilité d'une maladie rénale chronique de stade 3-5.				
Une évaluation du RAC urinaire est requise afin d'éliminer complètement ou de confirmer un diagnostic de maladie rénale chronique.				

INTERPRÉTATION

LES ANALYSES RÉFÉRÉES NE FONT PAS

PARTIE DE L'ACCREDITATION ISO 15189

D. Gauthier PhD., CSPQ, FCACB,

Biochimiste clinique

A. Ibrahim, M.D.C.M., FRCPC, Microbiologiste

Date Reçu	Finalisé	Imprimé le :	REQUÊTE	6788498	Final
2026-03-06 15:34	2026-03-06 19:00	2026-03-06 19:01			

RAPPORT DE LABORATOIRE CONFIDENTIEL

Copie PDF

LÉGENDE: ↓ Anormal Bas ↑ Anormal Élevé ↓ Alerte basse ↑ Alerte élevée ↓ Critique Bas ↑ Critique Élevé Page 1 / 3



130-275, boul. Armand-Frappier, Laval (QC) H7V 4A7

Prélevé 2026-03-06 09:01

Requérant

Médecin:

OUELLET-DECOSTE, ARIANE

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A 1H6

Tel: 514-400-7070, Fax :877-661-0185-AUTOFAX

Compte: VITALAB INC.

ENDOCRINOLOGIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
----------	-----------	-----------	--------	----

LH <0.5 UI/L

Folliculaire: 1.9 - 14.6
Ovulatoire: 12.2 - 118.0
Lutéale: 0.7 - 12.9
Post-ménopausée: 5.3 - 65.4

PROGESTÉRON 0.5 nmol/L

Valeurs de références:
Folliculaire: < 3.7
Ovulatoire: < 57.2
Lutéale: 3.4 - 83.6
Post-ménopause: < 0.7

ESTRADIOL <30 pmol/L

Folliculaire: 45 - 854
Ovulatoire: 151 - 1461
Lutéale: 82 - 1251
Post-ménopausée: <202

TESTOS. TOTALE <0.5 <2.0 nmol/L

TESTOS. LIBRE Note <29 pmol/L

La testostérone libre est estimée à partir des mesures de testostérone totale et de SHBG par l'algorithme de Vermeulen [J Clin Endocrinol Metab 84 (10):3666-3672, 1999].

Les résultats de testostérone libre peuvent être sous-estimés chez les patientes enceintes.

La testostérone libre ne peut être calculée car un des paramètres est en dehors de la linéarité.

SHBG 200 ↑ 17 - 125 nmol/L

PROLACTINE 16 5 - 24 µg/L

Immunodosage par électrochimiluminescence (ECLIA) de Roche Diagnostics. Les valeurs obtenues avec différentes méthodes d'analyse ou kits pourraient ne pas être identiques et ne peuvent pas être utilisées de façon interchangeable.

INSULINE AC 135 15 - 174 pmol/L

β-hCG QUANTITATIF <1 UI/L

Non enceinte pré-ménopause: < 5

Équivoque (peut indiquer une grossesse récente): 5 - 9

Post- ménopause: < 8

Semaines post menstruations : hcg niveaux approx.

3 sem: 6-71 5 sem: 217-7138

4 sem: 10-750 6 sem: 158-31795

7-12 sem: 3697-210612 14 sem: 13950-62530

Patient

F 1972-03-03 50 Ans

SWO000017600

6788498

CONTRACTS QV

BIOCHIMIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
----------	-----------	-----------	--------	----

LIPIDES :

Risque MCV
10 ans

Initier
traitement

Cibles
traitement

Risque faible
(<10%)

si LDL-C
≥5.00mmol/L

Réduction LDL-C
≥50%

Risque modéré
(10-19%)

si LDL-C
≥3.50mmol/L
ou apo B ≥1.20g/L
ou non-HDL-C
≥4.30mmol/L

LDL-C ≤2.00mmol/L
ou réduction ≥50%
Cibles alternatives:
Apo B <0.80g/L
non-HDL-C ≤2.60mmol/L

Risque élevé
(≥20%)

Tous les patients

LDL-C ≤2.00mmol/L
ou réduction ≥50%
Cibles alternatives:
Apo B <0.80g/L

LES ANALYSES RÉFÉRÉES NE FONT PAS

D. Gauthier PhD., CSPQ, FCACB,

PARTIE DE L'ACCREDITATION ISO 15189

Biochimiste clinique

A. Ibrahim, M.D.C.M., FRCPC, Microbiologiste

Date Reçu	Finalisé	Imprimé le :	REQUÊTE	6788498	Final
2026-03-06 15:34	2026-03-06 19:00	2026-03-06 19:01			

RAPPORT DE LABORATOIRE CONFIDENTIEL

Copie PDF

LÉGENDE: ↓ Anormal Bas ↑ Anormal Élevé ↓ Alerte basse ↑ Alerte élevée ↓ Critique Bas ↑ Critique Élevé Page 2 / 3



130-275, boul. Armand-Frappier, Laval (QC) H7V 4A7

Prélevé 2026-03-06 09:01

Requérant

Médecin:

OUELLET-DECOSTE, ARIANE

1172 RUE SHERBROOKE O

MONTREAL, QC, H3A 1H6

Tel: 514-400-7070, Fax :877-661-0185-AUTOFAX

Compte: VITALAB INC.

ENDOCRINOLOGIE

Analyses	Résultats	Référence	Unités	SE
16 sem: 9040-56451	15 sem: 12039-70971			
17 sem: 8175-55868	18 sem: 8099-58176			
CORTISOL AM	495	130 - 540	nmol/L	
DHEA-S	2.3	1.0 - 7.0	µmol/L	

Patient

F 15-03-1972 50 Ans

SWO000017600

PA [REDACTED]

SA [REDACTED]

Mont [REDACTED]

Tel [REDACTED]

6788498

CONTRACTS QV

LES ANALYSES RÉFÉRÉES NE FONT PAS

PARTIE DE L'ACCREDITATION ISO 15189

D. Gauthier PhD., CSPQ, FCACB,

Biochimiste clinique

A. Ibrahim, M.D.C.M., FRCPC, Microbiologiste

Date Reçu	Finalisé	Imprimé le :	REQUÊTE	6788498	Final
2026-03-06 15:34	2026-03-06 19:00	2026-03-06 19:01			

RAPPORT DE LABORATOIRE CONFIDENTIEL

Copie PDF

LÉGENDE: ↓ Anormal Bas ↑ Anormal Élevé ↓ Alerte basse ↑ Alerte élevée ↓ Critique Bas ↑ Critique Élevé Page 3 / 3